

# Protocolo de ejercicio terapéutico y plan domiciliario

Protocolo | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

## 1. Objetivo y resultado esperado

Acordar una carga de actividad que mejore función y sea tolerable, con objetivos, progresión y vigilancia.

## 2. Alcance y condiciones de uso

Utilizar únicamente para la intervención realmente ofertada, con recursos y competencia comprobados. Requiere valoración, consentimiento específico cuando procede, manual de equipos y registro clínico autenticado.

## 3. Responsabilidades por rol

| Rol                        | Responsabilidad                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta responsable | Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.   |
| Ejecutor según proceso     | Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia. |
| Verificador o titular      | Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.      |

## 4. Recursos y preparación

Zona segura de ejercicio; camilla o silla, ayudas y material elegido; instrumentos para medidas pertinentes y apoyo según riesgo.

## Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

### 1. Verificar nombre completo e identificación, motivo, objetivo y evolución desde la última a

Verificar nombre completo e identificación, motivo, objetivo y evolución desde la última atención. Revisar el plan y consentimiento; explicar el contacto, equipo y posibilidad de detener, antes de preparar la técnica.

### 2. Valorar y documentar: Capacidad funcional, síntomas, restricciones posoperatorias, riesgo

Valorar y documentar: Capacidad funcional, síntomas, restricciones posoperatorias, riesgo cardiovascular, movilidad y metas del paciente. Registrar lo encontrado y la decisión de continuar, modificar, aplazar o remitir. No copiar una lista como si hubiera sido evaluada.

### 3. Preparar el ambiente, privacidad, ayudas y dispositivos que la intervención requiere; insp

Preparar el ambiente, privacidad, ayudas y dispositivos que la intervención requiere; inspeccionar integridad, limpieza y funcionamiento. Confirmar disponibilidad de recursos para detener y responder ante complicación.

### 4. Aplicar con este criterio específico: Elegir ejercicios, frecuencia, intensidad, duración,

Aplicar con este criterio específico: Elegir ejercicios, frecuencia, intensidad, duración, descansos y asistencia con base en valoración. Registrar la dosis real y criterio de progresión, sin series o resistencia universales. La programación, medidas o dosis deben poder reconstruirse desde la historia de la sesión.

### 5. Vigilar y utilizar los siguientes criterios de interrupción: Dolor torácico, disnea despro

Vigilar y utilizar los siguientes criterios de interrupción: Dolor torácico, disnea desproporcionada, desmayo, deterioro neurológico, dolor intenso inesperado o pérdida de equilibrio requieren detener y evaluar urgencia. Primero controlar el riesgo y atender a la persona; después documentar y analizar el evento.

### 6. Cerrar y reevaluar con estas actividades: Enseñar y observar ejecución, adaptar carga y en

Cerrar y reevaluar con estas actividades: Enseñar y observar ejecución, adaptar carga y entorno, entregar plan domiciliario con señales de alarma y reevaluar desempeño y participación. Registrar conducta y autoría, acordar fecha o condición de seguimiento y comprobar comprensión de las recomendaciones.

## Control, frecuencia y corrección

### 5. Verificación de la ejecución

Antes de cada sesión: elegibilidad, consentimiento, recursos y cambios clínicos.

Durante: vigilancia proporcional a la técnica; nunca usar un consentimiento como sustituto de contraindicación.

Después: respuesta, piel cuando procede, educación, limpieza, registro y seguimiento.

Indicador local: sesiones con parámetros y respuesta trazables / sesiones revisadas x 100.

| Momento       | Comprobación y conducta                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes         | Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.  |
| Durante       | Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso. |
| Después       | Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.   |
| Ante hallazgo | Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.  |

### 6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

### 7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

### 8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

# Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Paciente e identificación               |  |
| Fecha hora sesión                       |  |
| Objetivo y diagnóstico fisioterapéutico |  |
| Tamizaje y precauciones                 |  |
| Consentimiento y autenticación          |  |
| Técnica región posición                 |  |
| Equipo código y parámetros reales       |  |
| Vigilancia y respuesta                  |  |
| Educación alarmas y conducta            |  |
| Autor y autenticación                   |  |

## Fuentes y límites

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576